

複雑性を抱擁する：保健人材強化のためのシステム思考

— WHO/NHS England ウェビナー（2026 年 1 月）から学ぶ —

対象：研修医・専攻医 | 15 分 | ガニエの 9 教授事象

問いの投げかけ

あなたの患者さん、何個の問題を同時に抱えていますか？

- 75 歳の外来患者。糖尿病、高血圧、変形性膝関節症、軽度認知機能低下、独居
- 内科に行けば「HbA1c 下げましょう」、整形に行けば「体重減らしましょう」
- ** 問い **: この患者のケアを「最適化」とはどういう意味か？

各専門科が個別に「正しい」ことをしても、全体として患者に最適とは限らない。

これが ** システム思考 ** が必要な理由です。

学習目標

この勉強会の後、あなたは：

1. ** 説明できる **: システム思考の基本概念（フィードバックループ・創発・レバレッジポイント）を自分の言葉で説明できる
2. ** 分析できる **: 臨床ケースを「システム」として捉え、因果ループ図で可視化できる
3. ** 設計できる **: 多職種連携を「システム介入」として計画する視点を持てる

** ブルーム分類法 **: 理解 → 分析 → 創造

背景知識の確認

あなたが既に知っていること

- ** 多職種連携（IPW: Interprofessional Work） **: 異なる職種が協働するという概念
- ** 生物心理社会モデル（BPS Model） **: 疾患を生物・心理・社会の3軸で捉える
- ** PDCA サイクル **: Plan-Do-Check-Act の改善ループ

今日はここに「システム」の視点を加えます

従来の考え方 | システム思考

問題→原因→解決 | 問題→構造→パターン→メンタルモデル

部分の最適化 | 全体の最適化

線形因果 | 循環因果（フィードバックループ）

コントロール | 影響（influence）

WHO の提言 ― システム思考とは

WHO/NHS England ウェビナー（2026 年 1 月 27 日）の核心メッセージ

「保健人材は孤立した労働力ではなく、 ** コミュニティ・教育・技術・財政・リーダーシップ ** を包むエコシステムの中にある」

― Working for Health 2030 シリーズ 第 1 回

3 つのパラダイムシフト（WHO/AHPSR, 2009→2026）

1. ** 部品から関係性へ **: WHO の 6 つの構成要素（Building Blocks）は独立した部品ではなく、フィードバックループで繋がる
2. ** 処方的コントロールから反復的学習へ **: トップダウンの「正解」ではなく、ステークホルダーの知恵を引き出す協働プロセス
3. ** アウトカム測定から文脈理解へ **: 「何が効くか」だけでなく「誰に、なぜ効くか」を問う

システム思考の 3 つの核心概念

1. フィードバックループ

医師不足 → 一人あたり業務量増加 → バーンアウト → 離職 → さらなる医師不足

- **** 強化型ループ (R) ****: 変化が変化を加速する (悪循環 or 好循環)
- **** バランス型ループ (B) ****: 変化を安定させる方向に働く (ホメオスタシス)

2. 創発 (Emergence)

- 個々の要素の性質からは予測できない、全体として現れる特性
- 例：「優秀な医師」 + 「優秀な看護師」 ≠ 「優秀なチーム医療」
- チームの文化、コミュニケーションパターンが「創発」する

3. レバレッジポイント (Donella Meadows)

- ** 小さな介入で大きな変化を生む場所 **
- 薬の増量ではなく、服薬指導の「場」を変えるだけで adherence が改善する
- 「どこを押すか」ではなく「システムのどこに介入するか」

■■■■ ■■■■ ■■■■

臨床ケースで因果ループ図を描こう

ケース：退院調整がうまくいかない 85 歳女性

- 大腿骨頸部骨折で入院 → 術後リハビリ中
- 独居、娘は遠方、要介護申請中
- 退院カンファレンスで「施設入所」と「自宅退院 + 訪問リハ」で意見が割れる

** ペアワーク（5分） **:

1. このケースに関わる「アクター」を全て書き出す（患者・家族・医師・看護師・PT・MSW・ケアマネ・地域包括…）
2. アクター間の「影響」を矢印で繋ぐ
3. ** フィードバックループ ** を1つ以上見つける
4. ** レバレッジポイント ** はどこか？

ヒント：「情報の流れ」と「意思決定のタイミング」に注目

全体共有とフィードバック

よくある発見パターン

- ** 情報の非対称性ループ **: MSW だけが知っている介護保険情報 → 医師の判断が変わる → でも MSW への相談タイミングが遅い → 退院延長
- ** 患者の意向が最後に来るループ **: 各職種が「最善」を提案 → 患者に選ばせる → 「お任せします」 → 本当の希望が見えない
- ** レバレッジポイントの例 **: 入院 48 時間以内に MSW が介入するルール = 情報ループの早期接続

WHO の問いを臨床に翻訳すると

「どの介入を追加すべきか？」ではなく「システム全体はどう反応するか？」

振り返りの問い

****1 分間リフレクション****（各自で）：

1. 今日の学びで、明日から自分の臨床で ****1 つだけ変えるとしたら**** 何か？
2. 自分が関わっている患者ケアの中で、 **** 悪循環のフィードバックループ**** が見えるケースはあるか？
3. その悪循環に対する **** レバレッジポイント**** はどこか？

持ち帰りの問い + 参考文献

次のカンファレンスで試してみよう

- 症例プレゼンのときに「このケースのシステム図」を1枚描いてみる
- 「なぜうまくいかないか」を**人の能力**ではなく**構造**で説明してみる
- 多職種カンファレンスで「この介入はシステムの他の部分にどう影響するか？」と問いかけてみる

深めたい人へ

リソース | ポイント

WHO — Embracing Complexity (2026) | 保健人材をエコシステムとして捉える公式フレームワーク

Donella Meadows — Thinking in Systems (2008) | レバレッジポイントの原典、システム思考のバイブル

AHPSR — Systems Thinking for HSS (2009) | WHO の 10 ステップフレームワーク、1,500 以上の引用

Peter Senge — The Fifth Discipline (1990) | 学習する組織、5つのディシプリン

ソース

- [WHO — Embracing Complexity: Systems Thinking for Health Workforce](<https://www.who.int/news-room/events/detail/2026/01/27/default-calendar/embracing-complexity--systems-thinking-for-health-workforce-strengthening>)
- [AHPSR — Systems thinking for health systems strengthening](<https://ahpsr.who.int/newsroom/news/item/02-02-2026-systems-thinking-for-health-systems-strengthening-changing-the-frame>)